尿路感染 ★★★（0~3 题）

- 概述 —— 上行 / 逆行性感染多见（女性多见，2023），大肠杆菌多见（2017、2026）
- 复杂性尿感（2006、2013） ——
  - ①清洁中段尿细菌培养≥ 10 万 /ml
  - ②伴泌尿系统结构或功能异常，或合并其他易发感染的基础疾病
- 无症状细菌尿 / 隐匿性尿感需短程疗法的情况（2005、2015） —— 妊娠、即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术患者
- 检查
  - 硝酸盐还原试验（筛查）：G- 菌阳性
  - 几乎有脓尿（WBC ＞ 5/HP）
    部分有血尿（RBC ＞ 3/HP）、蛋白尿（＞ 0.15g/d）
  - 真性细菌尿 / 清洁中段尿细菌培养等：急性尿感金标准（2007）
  - 静脉肾盂 / 尿路造影 IVP/IVU：慢性肾盂肾炎金标准
  - 多见于肾盂肾炎（2018、2021） ——
    - 血白细胞和 C 反应蛋白升高、血液细菌培养阳性、白细胞管型、尿 NAG ↑、尿 β_2-MG ↑
    - 输尿管导尿或膀胱冲洗后尿培养阳性、肾小管功能受损如尿比重和渗透压↓（慢性多见）
- 尿频尿急尿痛明显脓尿（2023）

  可能可能最可能

  留取尿细菌检查标本后立即开始治疗：磺胺类、青霉素类如阿莫西林、头孢菌素类、喹诺酮类“尿黄莫偷窥啊”（2022）

  - 急性膀胱炎（2018、2024）
    - 无全身症状
    - 治疗 ——
      - 年轻未孕女性：3 日（2018）
      - 免疫力低下、糖尿病、老年、妊娠、男性：7 日
  - 急性肾盂肾炎（2006、2008、2012、2017、2021、2022）
    - 白细胞管型、肾区叩痛、全身症状（T ＞ 38℃、血 WBC ↑），部分患者没有膀胱 / 尿道刺激症
    - 若体温再度升高 + 腰痛剧烈、绞痛→并发肾乳头坏死
    - 治疗 ——
      - 2 周“三膀二肾”（2008、2021、2022）
      - 复发（病原体与上次完全相同“复婚”，2019）：6 周
      - 半年内发作 2 次以上：6 月（长程低剂量抑菌）
  - 慢性肾盂肾炎（2026） ——
    - 慢性病程、单侧或双侧肾不对称缩小、IVP 肾盏肾盂变形缩窄
    - 持续小管浓缩等功能受损如尿比重和渗透压↓（2010、2014、2026）
    - 可有肾小球滤过下降（血 Cr 和 BUN ↑）